EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 80136
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-03-06 08:04:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: JUANA LINA ESCAMILLA ESCAMILLA			RUN	: 4.489.349-5
F.Nac	: 23-09-1940	Edad	: 83 AÑOS, 5 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: SAN GREGORIO, CALLE ESTADO 135			Comuna	: NIQUEN
Previsión	: FONASA B	Teléfono	:		
Fecha Ingreso	: 2024-02-16	Fecha Egreso	: 2024-03-06 08:04:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. R73.9-HIPERGLICEMIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. SHH resuelto
2. DM2 IR HbA1c 7.2%
3. UPP sacra 20x10 cm con tejido granulatorio y talon d°
4. AKI KDIGO I sobre ERC etapa IV vs progresión ERC.
5. NAC ATS III tratada
6. HTA
7. Alzheimer
8. Hipotiroidismo
9. Dependencia severa ABVD
10. Usuaria de SNG

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N18-ENFERMEDAD RENAL CRONICA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente Femenina De 83 Años De Edad Con Antecedentes De Hta Sistemica, Dmir, Alzheimer, Hipotiroidismo, Erc Quien Fue Derivada De Consultorio Por Hiperglicemia Y Clinica Respiratoria De 2 Semanas De Evolucion. Paciente Ingresa Al Su Hsc Deshidratada, Con Glicemia Plasmatica > 600mg/Dl Sin Acidosis, Reagudizacion De La Falla Renal Por Lo Que Realizan Manejo Inicial En Contexto De Estado Hiperosmolar Permaneciendo Dicho Manejo En Su Servicio Por Mas De 48 Horas Con Resolucion De Descompensacion Metabolica Sin Embargo Paciente Persiste Con Mal Manejo De Secreciones Y Control Rx Torax Impresiona Foco Con Tendencia A Consolidacion A Nivel Pulmonar Derecho Por Lo Que Se Ingresa Para Continuar Manejo. Con Tto Atb De Primera Liena Con Mejoría De Su Cuadro Clínico, Paciente Con Peaks Febriles Persistentes, Procalcitonina Elevada, Test Antigeno Sars Cov 2 (-), Por Lo Que Se Solicita Prc Para Cv19. Se Escala Tto Atb De Segunda Línea. Se Ajusta Dosis De Insulina Para Regularizar Valores Glicemicos (Se Aumenta: 22u Am- 16u Pm) Actualmente En Su Basal En Condiciones De Alta Medica.

En Condiciones De Cuidado Generales, Sin Requerimiento De Oxígeno, Vigil, Responde A Estimulos, Desconectada Con Medio. Pupilas Isocoricas Normorreactivas, Leucocoria Derecha, Llene Capilar Menor A 2 Segundos. Mucosa Normocoloreadas Y Secas. Rr2tss. Mp (+) Crepitos Bibasales Predominio Derecho. Abdomen Bdi Rha +
Mmii Con Atrofia Muscular Severa, Sin Edema, Sin Signos De Tvp, Pulsos Pedios Presentes.

PLAN DE MANEJO:

Alta Domicilio Con Hospitalización Domiciliaria
Kine Motora Y Respiratoria
Tratamiento Crónico
Control por APS
Control Sos Urgencia

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo Relativo Asistido
2. Regimen papilla por sng
3. Prevención Upp
4. Knt Motora Y Respiratoria
5. Curación De Upp Por Enfermería Según Necesidad
6. Bromuro De Ipratropio 4 Puff C/8Hrs Por Ac
7. Salmeterol Fluticasona 2 Puff C/12 Hrs Por Ac
8. Insulina Nph 22 Ui Am 16 Ui Pm Sc
9. Famotidina Comprimido 40 Miligramos 1 Comprimido Cada 24 Hrs. Por 1 Dias Via Oral
10. Lactulosa Solución 65% Frasco 200 Minilitros 15ml C 8hrs Sng
11. Hidralazina Comprimido 50 Miligramos 1 Comprimido Cada 24 Hrs. Por 1 Dias Via Oral
12. Levotiroxina Comprimido 100 Microgramos / Dosis 1 Comprimido Cada 24 Hrs. Por 1 Dias Via Oral
13. Quetiapina Comprimido 25 Miligramos 2 Comprimido Cada 24 Hrs. Por 1 Dias Via Oral
14. Paracetamol Comprimido 500 Milígramos 2 Comprimido Cada 8 Hrs. Por 1 Dias Via Oral

EXÁMENES Y RESULTADOS

Laboratorio 16/02 Glicemia 277, Albumina 3.1, Crea 2.7, Calcio 8.7, TFG 16.8, PCR 7.4, BUN 85, Na 145, K 5.1, Cl 120
Leucocitos 14.000, hb 12.2, Hcto 36.8, plaquetas 218.000, VHS 24

19/02 PCR 146, Crea 4.1, Uremia 244, PCR 13, Na 152, GB 16.6

lab 21/02 -> albumina 2,3; crea 3,5; calcio 7,3; LDH 464; lactato 0,8; PCR 20,4; BUN 130, uremia 279; Na/K/Cl 149/4.8/125; Gb 10,7; Hb/Hcto 9.5/28.6; plaq 163000; segment 84%; procalcitonina 0,7

Lab 27/02: Crea 2.4 TFG 19.28 LDG 452, lactato 0.9, PCR 29.6, Na 148, K 4.6, Cl 123 INR 1.26, TTPa 27, TP 16.6 Orina 26/02: hematíes 0-2 por campo, leucocitos 0-2 por campo, no se observan cilindros ni cristales. Nitritos negativos.
HCT 1 y 2 negativos.

Ex de laboratorio 4/3 : glicemia 116, albumina 1,9 crea 1,80, clearence 26,87 , lactato 0,6 pcr 55, sodio 135,00 potasio 4,50 cloro 111,00
hmoglobina 8,2 hto 24,2 lec 9,20 plaquetas 184,000 seg 80, linf 7. procalcitonina 0,54

CARABALLO DE HURTADO
JENNIFER DEL CARMEN
MEDICO TRATANTE

JEFE SERVICIO